

Locomoteur

Anamnèse

1. Caractériser la douleur
 - a. Localisation
 - i. Localisation précise
 - ii. Mono-articulaire ou poly-articulaire
 - b. Irradiation
 - c. Chronologie
 - i. Début
 - ii. Circonstance de survenue ? traumatisme ? craquement ?
 - iii. Évolution (fluctuation)
 - iv. Diurne / nocturne (→ inflammatoire vs mécanique)
 - d. Intensité
 - e. Qualité
 - i. Brûlures
 - ii. Décharge électrique
 - iii. Sensation de froid douloureux
 - iv. Fourmillement
 - v. Picotement
 - vi. Démangeaison
 - vii. Engourdissement
 - f. Facteurs aggravants/soulageants
 - i. Douleur au mouvement ? ou amélioré par le mouvement ? → (inflammatoire vs mécanique)
 - g. Rachis
 - i. Hypoesthésie au tact
 - ii. Hypoesthésie à la pique
2. Blocage ? instabilité ?
3. Symptômes associés
 - a. **Fièvre (!!! arthrite septique)**
 - b. Tuméfaction ?
 - c. Rouge ?
 - d. Chaud ?
4. Impact sur la vie quotidienne ?
 - a. Hanche
 - i. Périmètre de marche
 - ii. Escalier
 - iii. Position assise confortable ?
 - iv. Capable de mettre ses chaussures, chaussettes ?
 - b. Genou
 - i. Périmètre de marche
 - ii. Escalier
 - c. Membre supérieur
 - i. Arrive à se faire à manger ?
 - ii. Arrive à se laver ?
 - d. Escaliers chez lui ? vit où ?
5. Métier ?
 - a. Empêche de travailler ?
6. ATCD personnel
 - a. Maladie

- b. Opération
 - c. Hospitalisation
 - d. Médicament
 - e. Allergie
- 7. ATCD familiaux
 - a. Maladie rhumatismale

DD

Douleurs inflammatoires vs douleurs mécaniques

- Douleurs inflammatoires
 - o Nocturnes
 - o De repos
 - o Réveil nocturne
 - o Raideur matinale
 - o Amélioration pas l'activité
- Douleurs mécaniques
 - o Diurne
 - o Douleur au mouvement
 - o Dérouillage mais pas de raideur

Rachis

- *Myélopathie (démarche ataxique, perte de la motricité fine, réflexes pathologiques, signes pyramidaux)*
- *Radiculopathie (douleur neuropathique, intense, lancinante, souvent unilatérale, selon un dermatome, paresthésies, reproductibles par l'étirement, hypoesthésie, atrophie, abolition des réflexes)*

Genou

- *Lésion ligamentaire*
 - o LCA
 - o LCP
 - o LLI
 - o LLE
 - o Déchirure méniscale
 - o Lésions de l'appareil extenseur

Status moodle : <https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=17498#section-2>

Hanche

Examen clinique (en sous-vêtement, sans chaussette)

1. Marche : 6 allers-retours + talon + pointe

- Boiterie :
 - D'esquive
 - Trendelenburg
 - Duchenne
 - Dandinante
 - Inégalité de longueur
- Axe des jambes
 - Valgus / Varus

2. Posture :

- Horizontal : épaule, hanche
- Colonne droite
- Se pencher en avant / de côté

3. Hanche

1. Inspection

- Atrophie : regarder glutéaux avant qu'il se couche

SE COUCHER

- Cicatrices - Rougeur - Œdème - Hématome
- Position vicieuse
- Atrophie quadriceps

2. Palpation

- Grand trochanter
- Pli inguinal
- Muscle (quadri)

3. Mobilisation : actif (si limité → musculaire) et passif (si limité → articulaire)

- Flexion (90°) - Extension (écraser la main) (0°)
- Abduction (30°) - Adduction (10°)
- Rotation interne (pied sur l'extérieur) (10°) - Rotation externe (pied sur l'intérieur) (30°)
- **FADIR** (flex-add-rot int) - **FABER** (flex-abd-rot ext)
- Flexion contre résistance
- Abduction contre résistance
- Signe du 4 (talon sur genou)
- + exclure atteinte neuro : Babinski, lasègue, lasègue inversé

Penser aux douleurs référées du genou → peut être utile de faire aussi un examen de la genou (arthrose du genou peut faire douleur au pli de l'aine)

Genou

Penser aux douleurs référées de la hanche → peut être utile de faire aussi un examen de la hanche

1. Stabilité (si pas trop douloureux)
 - Marche
 - Squat complet + se relever : si arrive à remonter sans les mains → quadri Q ischio-jambiers assez fort
 - Squat unipodal : d'abord jambe non douloureuse
2. Inspection
 - DEBOUT
 - Creux poplité
 - Atrophie fessier
 - COUCHER
 - Cicatrices
 - Axe du MI : soulever le pied et chez l'espace entre les genoux + flessum/recurvatum (le flessum est mieux vu couché sur le ventre)
 - Longueur : malléole interne au même niveau ? longueur entre épine iliaque et malléole interne
 - Tuméfaction : **signe du glaçon**
 - Chaleur
 - Rougeur
3. Palpation
 - Muscle
 - Tendon
 1. Au-dessus/dessous de la rotule
 2. Patte d'oie → tibia
 3. Bandelette ilio-tibiale → fibula
 - Os (légère flexion)
 1. 2 condyles fémoraux
 2. Plateau tibial
 3. Tête de la fibula
 4. Facette patellaire en extension
 5. Creux poplité
4. Mobilisation
 - Flexion - Extension
5. Test du genou
 - Ligaments
 1. Collatéraux
 - a. En extension complète
 - b. En flexion à 30° (mettre notre genou sous celui de la patiente)
 2. Croisé antérieur
 - a. Test de Lackman
 - b. Test du tiroir antérieur
 3. Croisé post
 - a. Tenir les 2 pieds à l'éclair
 - b. Tiroir post

- Ménisque

4. Test de Mc Murray
 - a. Flexion/extension en rotation lat → ménisque interne
 - b. Flexion/extension en rotation méd → ménisque externe
5. Appuyer sous rotule int et faire flexion/extension passive
6. Idem avec ext
7. Test sur le ventre avec jambe fléchie à 90° → on fait des rotations tout en tenant le fémur → corne postérieure des ménisques

- Rotule

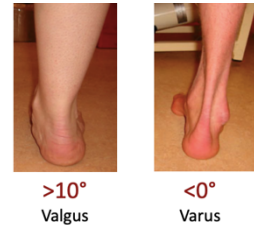
8. Test de l'appréhension quand on la pousse latéralement en faisant une flexion
9. J-sign (course rotulienne) : ASSIS AU BORD DU LIT

Pied

1. Marche

2. Inspection

- Chaussures
 - Pattern d'usure
- Peau
 - Cicatrices, lésions
 - Rougeur, pâleur
 - Hématome, tuméfaction
- Cheville
 - Valgus physiologique : 5 – 10°
 - Voir si le valgus se corrige sur la pointe des pieds
- Pied
 - Abductus – neutre -adductus
 - Appui arche longitudinale
- Orteils
 - Griffe

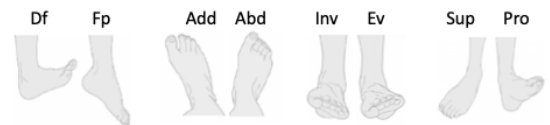


3. Palpation

- Vascularisation
 - Pouls (tibial post – pédieux)
- Nodule face plantaire
- Os
 - Fibula (jusqu'au genou si entorse de la cheville)
 - Malléole interne et externe
 - Talus - calcanéum – métatarsien (base du 5^{ème}) – phalange
 - Squeeze des métatarsien
- Tendons
- Points d'appui

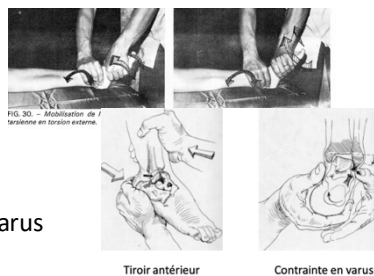
4. Mobilité active et passive

- Cheville – pied
 - Dorsiflexion (20°) – flexion plantaire (50°)
 - Adduction (20°) – abduction (10°)
 - Inversion (30°) – éversion (20°)
- Orteils
 - Flexion – extension des orteils



5. Test

- Couple de torsion
 - Chopart
 - Lisfranc
- Laxité de la cheville
 - Tiroir antérieur
 - Contrainte en varus
- Test de thompson



- Pts en décubitus ventral → appuyer avec les 2 mains sur le mollet → test + lors d'absence de flexion plantaire = rupture du tendon d'Achille

<https://www.youtube.com/watch?v=xFnWAjrTGHc>



Rachis

1. Marche
 - a. Normal
 - b. Talon
 - c. Pointe
 - d. Funambule
2. Inspection
 - a. Latéralement (LCL)
 - b. Postérieurement (scoliose)
 - c. Regarder colonne quand se penche en avant
3. Palpation
 - a. Épine iliaque → chez hauteur
 - b. L4-L5 → articulation sacro-iliaque (même ligne qu'épine)
 - c. Muscle paravertébraux
4. Percussion
 - a. Vertèbres
5. Examen
 - a. Cervicale
 - Dire oui de la tête – dire non
 - Toucher l'épaule avec l'oreille
 - b. Lombaire (DEBOUT)
 - Se pencher en avant
 - Se pencher un peu en arrière
 - Se pencher de chaque côté
 - **Test de Schober** : mettre le pouce sur L5 et mettre l'index sur le processus épineux 10 cm plus haut → patient se penche en avant → 15 cm entre les doigts si normal
 - **Signe de la sonnette** : appuyer fort sur L4 → signe positif si patient se crispe → suspicion de radiculopathie et décharge latérale à la jambe jusqu'à derrière le genou
 - c. Thoracique
 - Patients ASSIS → tourner les épaules les bras croisé
 - d. COUCHER
 - **Test de lasègue** : test positif si décharge dans la jambe entre 40° et 60°
 - **Test de Bragard** : = test de lasègue avec dorsiflexion
 - **Lasègue inversé**
 - Test de spurling (cervicales)
6. **Peut être utile de faire examen neuro ciblé**

Épaule

1. Inspection
 - a. Rougeur
 - b. Tuméfaction
 - c. Amyotrophie
 - d. Cicatrice
2. Palpation
 - a. Articulation sterno-claviculaire → longer la clavicule
 - b. Articulation acromio-claviculaire
 - c. Articulation gléno-humérale → tendon du biceps
 - d. Tendon de la coiffe des rotateurs
3. Mobilité : ACTIVE + PASSIVE
 - a. Flexion – extension
 - b. Abduction – adduction
 - c. Rotation médiale (distance C7 – pouce)
 - d. Rotation latérale (coude au corps et/ou bras à 90° d'abduction)
4. Évaluation des tendons
 - a. Supra-épineux
 - **Test de Jobe** : abduction à 90°, 30° de flexion antérieure, pouce vers le bas → examinateur exerce pression vers le bas
 - b. Infra-épineux et petit rond
 - **Rappel en rotation interne** : patient doit maintenir la position de rotation latérale
 - **Signe du battement de cloche** : patient doit faire rotation interne contre résistance, puis l'examineur lâche soudainement la résistance → le signe est positif si la main vient de taper le ventre (ne freine pas)
 - **Manœuvre de Patte** : rotation latérale en abduction contre résistance
 - c. Subscapulaire
 - **Lift off test de Gerber** : rotation médiale → maintenir main décollée du dos
 - **Belly press** (si lift off pas possible) : main contre le ventre et examinateur appuie sur le coude vers l'arrière
 - d. Biceps
 - **Palm up test** : coude tendu et paume vers le haut contre résistance
5. Conflit sous acromial
 - **Test de Neer** : stabiliser scapula (avec pouce derrière et main qui tient l'épaule) → flexion passive (patient doit être décontracté : main tombante) → test positif si douleurs entre 60° et 120°
 - Flexion de l'épaule et du coude → faire bascule de la main rapide (main vers le bas)
6. Test de laxité
 - a. **Test d'appréhension** : abduction 90° et flexion coude 90° → une main tient l'épaule et l'autre l'épaule (pouce en arrière) → essayer de faire sortir l'épaule (pousser la tête humérale en avant + légère rotation latérale=
 - b. **Recherche d'un tiroir** : bras pendant → mobilisation de la tête humérale
 - c. **Sulcus test** : traction vers le bas (coude à 90° le long du corps)

Coude

1. Inspection
 - a. Rougeur
 - b. Tuméfaction
 - c. Amyotrophie
 - d. Cicatrice
2. Palpation
 - a. Épicondyles de l'humérus
 - b. Olécrâne
 - c. Tête radiale
3. Mobilité ACTIF + PASSIF
 - a. Flexion – extension ($> 10^\circ$ = hyperlaxité)
 - b. Pronation – supination
4. Test des ligaments
 - a. Lig. Collatéral ulnaire – radiale
5. **Test de tinel** + sensibilité pour chercher une atteinte du n. ulnaire
6. **Signe de Popeye** + pas palpable en flexion 90° et supination = rupture du tendon du biceps

Main

1. Inspection

- Couleur - rougeur – érythème
- Température
- Pilosité
- Sudation – brille
- Tuméfaction – œdème
- Amyotrophie loge thénar / loge hypothénar
- Cicatrice – plaie
- Déformation

2. Palpation

- Radius
 - Processus styloïde
 - Tubercule dorsal
- Ulna
 - Processus styloïde
- Scaphoïde
- Pisiforme
- Capitatum
- Tabatière anatoie
- Métacarpiens
- Phalanges + squeeze test + grinding

3. Mobilisation

a. Poignet

- Flexion – extension
- Inclinaison ulnaire – radiale

b. Main

- Pouce
 - Opposition (avec le 5^{ème})
 - Abduction – adduction
 - Extension – flexion
- Doigt
 - Abduction – adduction
 - Flexion – extension
 - Flexion
 - Poingt
 - Toit
 - Flexion 3^{ème} doigt (tenir les autres) → fléchisseur sup
 - Flexion phalange distale 3^{ème} (tenir le doigt contre la table) → fléchisseur profond
 - Flexion 2^{ème} et 5^{ème}

4. Test ligamentaires collatéraux ulnaires et radial

- a. Méta-carpio-phalangiennes en flexion
- b. Inter-phalangienne en extension + en flexion à 30°

5. Vascularisation

- a. Pouls radial
- b. Test d'Allen
- c. Temps de recoloration capillaire

Dévascularisation :

- Doigts blancs
- Ne se remplit pas après pression
- Augmentation du temps de recoloration

6. Innervation

- a. Sensibilité
 - Globale
 - Si plainte
 1. Piquer → si anormal faire : toucher – piquer
 2. Pallesthésie
 3. Position haut – bas
- b. Moteur
 - Radial → thumbs up
 - Ulnaire → écarter les doigts
 - Médian → ok du plongeur

Syndrome du tunnel carpien :

- Symptômes
 - Engourdissement des doigts, sensation de main morte
 - Douleur et paresthésie localisée dans le territoire du n. médian
 - Surtout la nuit
- Status
 - Amyotrophie loge thénar
 - Test de Phanel IMAGE

Atteinte du n. ulnaire :

- Doigt en griffe ulnaire → 4 + 5 fléchi
- Test de Tinnel au coude
- Test de Froment IMAGE

Atteinte du n. radial :

- Main tombante

Tendinite de De Quervain :

- Test de Finkelstein IMAGE

Mallet Finger :

- Rupture du tendon de l'extenseur profonds des doigts → flexion (bosse) phalange distale

Pouce du skieur :

- Rupture du lig. latéral ulnaire
- !!! faire une radio avant de tester la laxabilité → exclure l'arrachement

Fracture du scaphoïde :

- Chute sur les mains
- Suspicion forte si palpation palmaire et dorsale du scaphoïde + tabatière anatomique douloureuse
- Test du piston (pousser pouce dans l'axe)
- Test d'instabilité scapho-ulnaire
 1. Inclinaison ulnaire et légère extension
 2. Bloquer le scaphoïde

3. Inclinaison radiale
→ positif si douleurs ou saut

Plaies de la main :

- Examen de la vascularisation → couleur, température, recoloration capillaire
 - Examen neuro → sensibilité
 - Examen tendineux (sup/prof)
 - Vaccin anti-tétanique
- Face dorsale : explorer chirurgicalement : examen clinique pas fiable
- Face palmaire : examen clinique